

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5110137-52.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci GRANDO

RECORRENTE: DANIEL SOUZA DA ROCHA ELISIARIO

RECORRIDO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EPINEFRINA AUTOINJETÁVEL. PACIENTE COM RISCO DE CHOQUE ANAFILÁTICO. INDISPONIBILIDADE DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA NO SUS. TEMA 500 E TEMA 1.161 DO STF. DEVER DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

5110137-52.2024.4.02.5101

510015593292 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5110137-52.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci GRANDO

RECORRENTE: DANIEL SOUZA DA ROCHA ELISIARIO

RECORRIDO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Medida de Urgência interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo Federal da 1ª VF do Rio de Janeiro [evento 3, DESPADEC1, autos de origem], que indeferiu tutela provisória de urgência que pretendia o imediato fornecimento de **Adrenalina (epinefrina) autoinjetável 0,15mg**.

Em apertada síntese, o autor, ora recorrente, é menor impúbere com quadro grave de alergia à proteína do leite vaca, apresentando anafilaxia (choque anafilático/edema de glote) quando exposto acidentalmente ao leite ou seus derivados. Assim, o médico assistente prescreve o medicamento Adrenalina (Epinefrina) autoinjetável 0,15mg, destacando a urgência e o risco de morte e o grave comprometimento do bem estar [evento 24, LAUDO2, fls. 16/20].

O recorrente postula pela tutela recursal de urgência, sustentando a presença dos requisitos legais. Aduz a **probabilidade do direito** através dos relatórios médicos anexos aos autos. Já o **periculum in mora** é justificado pelo risco de morte, no caso de exposição acidental à proteína do leite.

Deferida a tutela recursal [evento 29, DESPADEC1].

Contrarrazões pela União [evento 37, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que deferiu a liminar, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

"Em parecer técnico, o NAT-Jus confirma o quadro clínico do autor e a indicação do medicamento pretendido, onde informa que a apresentação autoinjetável (Epipen Junior®) não tem liberação pela ANVISA, sendo adquirida apenas por processo de importação. Confirma, ainda, a inexistência de substituto fornecido pelo SUS de forma autoinjetável [evento 27, PARECER1].

Isto posto, cumpre esclarecer que no RE 657.718, julgado em 22/05/2019, o Supremo Tribunal Federal fixou a premissa de que a concessão de remédios pelo Poder Público pressupõe o registro pela ANVISA, por se tratar de procedimento que garante segurança à saúde pública, com respaldo no artigo 19-T, II, da Lei nº 8.080/91.

Art. 19-T. São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS:

(...)

II - a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

Excepcionalmente, admite-se o fornecimento de medicamentos sem prévio registro na ANVISA, quando presentes três requisitos cumulativos: (i) existência de pedido de registro na autarquia; (ii) existência de registro em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) inexistência de substituto registrado. Vejamos:

Tese nº 500 em Repercussão Geral:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.

2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.

3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos:

I - A existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);

II - A existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e

III - A inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

Já em 2021, o STF fixou a Tese nº 1.161 em repercussão geral, em que admitiu o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, desde que possua autorização de importação pela autarquia. Nesta hipótese, devem ser comprovados (i) a incapacidade econômica do paciente para custear a importação; (ii) a imprescindibilidade do fármaco ao tratamento médico; e (iii) a inexistência de substituto na lista de dispensação do SUS.

Tese nº 1161 em Repercussão Geral:

Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na Anvisa, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

A respeito da **incapacidade de custear a importação**, o demandante instrui o feito com CTPS informando situação de desemprego de sua genitora e informando a renda mensal familiar de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para três pessoas [evento 24, LAUDO2, fls. 5/11].

Quanto à **imprescindibilidade do fármaco** ao tratamento médico e à **inexistência de substituto** na lista de dispensação do SUS, destaco o laudo médico que instrui o feito [evento 24, LAUDO2, fls. 16/20], indicando a imprevisibilidade do contato com o agente alergênico e a necessidade de rápida administração do medicamento para combater o choque anafilático. A indicação foi confirmada pelo parecer do NAT [evento 27, PARECER1], que também pontua a inexistência de substituto no SUS:

"Elucida-se ainda que, no momento, nas listas oficiais de medicamentos para dispensação pelo SUS, no âmbito do Município e do Estado do Rio de Janeiro, não constam alternativas terapêuticas que possam representar substitutos farmacológicos ao medicamento Adrenalina autoinjetável."

Registre-se precedente desta Turma Recursal, nos autos 5004637-13.2023.4.02.5107/RJ, de relatoria da Juíza Federal Dra. ALESSANDRA BELFORT BUENO, com julgamento à unanimidade na sessão ordinária de 07/08/2024:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ALERGIA ALIMENTAR GRAVE COM ANAFILAXIA. RISCO DE ÓBITO. MENOR IMPÚBERE. PRESCRIÇÃO DE EPINEFRINA AUTOINJETÁVEL. PRECEDENTES STF. RE 657718 (TEMA 500) E RE 1165959 (TEMA 1161).

IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA SIMILAR. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

*Por todo o exposto, entendo presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Federais, e **DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar às rés, solidariamente, o fornecimento do medicamento Adrenalina (epinefrina) autoinjetável 0,15mg pelo tempo que se fizer necessário, conforme critérios médicos, sob pena de não fazendo, ser determinado o sequestro ou bloqueio de suas verbas no montante necessário para custear o tratamento.***

Registre-se que desde a prolação da decisão referenciada, não foram apresentados novos fatos ou argumentos com vistas à sua revisão.

Não suficiente, as teses suscitadas em contrarrazões pela União, no sentido da inexistência de probabilidade do direito postulado e da existência de alternativas terapêuticas ofertadas pelo SUS, não sobrevivem aos fundamentos suscitados na decisão monocrática que deferiu a tutela recursal.

Destaco, neste sentido, que o próprio NAT-Jus confirma a imprescindibilidade do insumo e a inexistência de alternativa terapêutica ofertada pelo SUS, afastando as teses da União.

Logo, merece confirmação a decisão monocrática de deferimento da tutela recursal e, no mérito, merece provimento o recurso.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.